MÓDULO 6 · MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA MSLS

Evidencia del mundo real (RWE)

La FDA define los datos del mundo real (Real-World Data, RWD) como los datos relativos al estado de salud del paciente o a la prestación de asistencia sanitaria, recogidos rutinariamente desde fuentes muy diversas: historias clínicas electrónicas, registros de enfermedad, bases de datos de reclamaciones y facturación de aseguradoras, datos de dispositivos móviles y wearables, y datos aportados por los propios pacientes. La evidencia del mundo real (Real-World Evidence, RWE) es la evidencia clínica sobre el uso, los beneficios potenciales o los riesgos de un producto médico que se deriva del análisis de esos datos.

RWD Y RWE

- RWD: datos de historias clínicas, registros, reclamaciones y wearables
- RWE: evidencia clínica derivada del análisis de esos datos
- Ambos conceptos están definidos formalmente por la FDA

La RWE no es un tipo de estudio en sí misma, sino un tipo de fuente de datos que puede analizarse con distintos diseños: puede alimentar estudios observacionales de cohortes, análisis de bases de datos administrativas, registros de pacientes o incluso ensayos clínicos pragmáticos que se ejecutan dentro del propio sistema sanitario. Su relevancia ha crecido exponencialmente en la última década porque responde a una limitación estructural de los ensayos clínicos tradicionales: estos se ejecutan en poblaciones seleccionadas, en un periodo de tiempo limitado y en condiciones muy controladas, mientras que la RWE permite observar cómo se comporta un tratamiento en la diversidad real de pacientes, en la práctica clínica cotidiana, y durante periodos de seguimiento mucho más largos.

- La RWE es un tipo de fuente de datos, no un tipo de estudio
- Puede alimentar cohortes, registros, bases administrativas o ensayos pragmáticos
- Responde a la limitación de los ECA: poblaciones selectas y seguimiento corto

Las agencias reguladoras han reconocido formalmente este valor. La FDA cuenta con un marco específico para el uso de RWE en la toma de decisiones regulatorias desde 2018, y la ha utilizado históricamente para vigilancia poscomercialización de seguridad, y de forma creciente también para apoyar decisiones de efectividad, ampliaciones de indicación o el diseño de estudios comparativos cuando un ensayo aleatorizado tradicional no es factible o ético. La Agencia Europea del Medicamento sigue una trayectoria similar a través de iniciativas como DARWIN EU, su red de datos del mundo real a escala europea.

- La FDA tiene un marco específico para usar RWE en decisiones regulatorias desde 2018
- Se usa para vigilancia poscomercialización y ampliaciones de indicación
- La EMA sigue una trayectoria similar con su red DARWIN EU

Para un MSL, la RWE tiene aplicaciones muy concretas. Permite responder preguntas que un HCP formula constantemente y que ningún ensayo pivotal puede contestar del todo: "¿cómo se comporta este tratamiento en pacientes mayores de 75 años con insuficiencia renal?", "¿qué persistencia real tiene este tratamiento fuera del ensayo?", "¿cómo se compara frente a la alternativa en la práctica diaria de mi hospital?". También es una fuente esencial para identificar gaps de evidencia —preguntas relevantes para la práctica clínica que aún no tienen respuesta— que después pueden convertirse en propuestas de estudios observacionales o en colaboraciones de investigación.

APLICACIONES DE LA RWE PARA EL MSL

- Responde preguntas de HCP que el ensayo pivotal no puede contestar
- Ayuda a identificar gaps de evidencia aún sin respuesta
- Esos gaps pueden convertirse en estudios observacionales o colaboraciones

El MSL debe manejar la RWE con el mismo rigor crítico que cualquier otra evidencia: preguntarse por la fuente y calidad de los datos, por el método de ajuste estadístico usado para controlar la confusión, por la representatividad de la población y por la transparencia con la que se ha reportado la metodología, siguiendo marcos de buenas prácticas como los de ISPOR o STROBE.

- Exige el mismo rigor crítico que cualquier otra evidencia
- Preguntar por la fuente, calidad de datos y método de ajuste estadístico
- Seguir marcos de buena práctica como ISPOR o STROBE